ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Hôpital Henri-Mondor AP-HP

1, rue Gustave Eiffel
94000 CRETEIL
01.49.81.21.11

Madame Docteur Marianne I
CDS MUNICIPAL F DEWERPE
64 AVENUE GEORGES GOSNAT
94200 IVRY SUR SEINE

DMU Médecine

Service de Cardiologie
Pr Emmanuel TEIGER
Chef de Service

Unité de Soins Intensifs de Cardiologie

SOS ENDOCARDITE

SOS EMBOLIE PULMONAIRE

Pr Pascal LIM

Secrétariat :
Mme E.CHUPIN
Tel : 01.45.17.83.51
Mail : elodie.chaupin@aphp.fr
Mme A.MARQUETTE
Tel:0145178351
Mail:alexie.marquette@aphp.fr

Dr R. HUGUET (PH)
Dr D. AOUATE (PH
Dr C.BOYER (CCA)
Dr M.KHOURY (CCA)
Dr A. BEN YOUNES (AHS)

CRETEIL, le 15/04/2025

Références : DSM/DSM

COMPTE RENDU D'HOSPITALISATION du 13/04/2025 au 15/04/2025

MOTIF D'HOSPITALISATION

Madame , née le 14/10/1952, âgée de 72 ans, a été hospitalisée du 13/04/2025 au 15/04/2025 pour Syncope - Suspicion de BAVc.

Mode de sortie : Domicile

MODE DE VIE

Vit en appartement au 3ème étage sans ascenseur
Veuve depuis 1 an
Autonomie relative
Originaire de Tunisie

ANTÉCÉDENTS

Antécédents médicaux :

- Cancer du sein droit en 2008 opéré par mastectomie en 2015
Cancer du sein gauche en 2024 traité par radiothérapie et Tamoxifène
Diabète de type 2 non insulino-dépendant
Asthme
Allergie: Pollens

Antécédents chirurgicaux :

- Cataracte sénile, sans précision (H259).

TRAITEMENT A L'ENTRÉE

Metformine 1000mg: 1-1-1
Tahor 10mg: 1 cp le soir
Tamoxifen
Ventoline
Aspegic 100mg : 1-0-0
Cardensiel 2.5mg: 1/2 cp le midi

Furosemide 40mg 1-0-0
Lercanidipine 20mg: 1-0-0
Triatec 1.25mg : 0-0-1
Cacit 500mg: 1-0-0
Zyma D 50 000 UI
Seretide 250/25µg : 2 inhalations le matin et le soir
Thealose : 1 gtte x3/jour

RESUME CLINIQUE - HISTOIRE DE LA MALADIE

Ce jour, alors qu'elle sortait faire ses courses, la patiente a ressenti un accès de vertiges, suivi quelques seconde après d'une perte de connaissance brutale, avec probable atonie associée, et sans mouvement anormal retrouvé (dans le dossier du SAMU), avec reprise relativement rapide de la conscience (se souvient d'un homme et d'une femme qui l'ont réveillé avec des secousses sur les joues), puis ses premiers souvenirs remontraient à l'arrivée du SAMU. La patiente ne décrit pas de douleur thoracique, ni dyspnée, ni palpitation avant ou après la perte de connaissance.

A l'arrivée du SAMU, il aurait été diagnostiqué sur le scope, mais non documenté sur un ECG, et non retrouvé à l'interrogation du scope du SAMU. La patiente est par la suite transférée à l'USIC du CHU Henri Mondor.

Evaluation de la douleur : EN = 0 (évaluation du 13/4/2025 23:55)

EXAMEN CLINIQUE A L'ENTRÉE

La pression artérielle est à 141/66 mmHg, la fréquence cardiaque est à 87 bpm, la saturation est à 97 % en air ambiant.
Poids 71 kg Taille 171 cm IMC 28 kg/m²
Pas de douleur thoracique, palpitations, lipothymies ou syncope. Dyspnée NYHA 4.
Absence de signes de bas débit.
Absence de signes d'insuffisance cardiaque droite ou gauche.
L'auscultation pulmonaire est claire.
Les bruits du cœur sont réguliers sans souffle.
Les pouls sont perçus aux 4 membres.
L'abdomen est souple indolore dépressible. Le reste de l'examen clinique est sans particularités.

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES RÉALISÉS À L'ENTRÉE

Biologie

HEMATOLOGIE - CYTOLOGIE

Numération				
Compte globules (…[1]		DXH2401		
Leucocytes	Giga/l	7.5		4.0-10.0
Hématies	Téra/l	3.9	-	4.2-5.4
Hémoglobine	g/dl	11.5	-	12-16
Hématocrite	%	34	-	36-48
VGM	fl	86		80-100
TCMH	pg	29		>27
CCMH	g/dl	34		32-36
IDR	%	15		<15
Plaquettes	Giga/l	332		150-400
VMP	fl	7.8		7.5-11.2

BIOCHIMIE

Examens sanguins				
Sodium	mmol/l	140		136-145
Potassium	mmol/l	3.8		3.4-5.0
Chlorure	mmol/l	100		98-107
Bicarbonate	mmol/l	27.0		22.0-29.0
Protéines sériques	g/L	73		64-83
Urée	mmol/l	10.3		<11.9
Créatinine	µmol/l	102	+	<80
DFG calculé par MDRD	mL/min/…	46…[1]	-	>90
DFG calculé par C…[2]	mL/min/…	47…[3]	-	>90

HEMATOLOGIE - CYTOLOGIE
Numération

Compte globules (…[1]		DXH2401		
Leucocytes	Giga/l	8.1		4.0-10.0
Hématies	Téra/l	3.8	-	4.2-5.4
Hémoglobine	g/dl	11.0	-	12-16
Hématocrite	%	32	-	36-48
VGM	fl	86		80-100
TCMH	pg	29		>27
CCMH	g/dl	34		32-36
IDR	%	15		<15
Plaquettes	Giga/l	291		150-400
VMP	fl	7.7		7.5-11.2

Imagerie

L'ETT, réalisé par le Dr URIEN, retrouve:
1) VG non dilaté (DTDVG= 5 cm), non hypertrophié (SIVd : 0.9 cm ; MVG : 94 g/m²), ressaut septal, sans autre trouble de la cinétique, FEVG préservée à 65 % en SBP. DC = 6.11 l/min, soit IC = 3.51 l/min/m².
2) Les pressions de remplissage du ventricule gauche sont non augmentées : E/A : 0.6 ; E/E' moy : 7.6, OG non dilatée (29 ml/m²), Vmax de l'Insuffisance Tricuspide à 2.54 m/s
3) Valve aortique est tricuspide, sclérose aortique sans Rétrécissement Aortique ni Insuffisance Aortique.
4) Pas d'Insuffisance Mitrale.
5) Le ventricule droit est de taille et de fonction normales (TAPSE = 2 cm, S' tricuspide = 15 cm/s). PAPs = 26mmHg + POD soit 29mmHg, sur le flux d'IT. VCI fine et compliante.
6) Péricarde libre
7) Aorte initiale non dilatée : Valsalva à 2.9 cm, JST à 2.6 cm, aorte tubulaire ascendante à 2.9 cm.

CONCLUSION:
- FEVG préservée, pas de valvulopathie mitrale ni aortique significative.

ECG

ECG du SAMU: Rythme Sinusal, FC variable entre 30 et 60 bpm, axe gauche, PR < 200ms, QRS élargis, aspect de Bloc de branche complet Gauche, trouble de la repolarisation secondaire. Le QTc est à 42 0ms. Passage en dysfonction sinusal avec FC = 30 bpm, et absence d'onde P bloquée.

ECG en USIC: RS, FC = 85 bpm, axe gauche, PR < 200ms, QRS fins, trouble de la repolarisation secondaire, QTc = 470ms.

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES RÉALISÉS PENDANT LE SÉJOUR

Autres

IMPLANTATION PACE MAKER DU 15/04/2025

- Opérateurs: Dr LABBE Jean Philippe, Pr LELLOUCHE Nicolas
- Durée procédure: 60 min, scopie : 4 min 0 s.
- PDS total : 221 cGy.cm².
- Air Kerma cumulé : 144 mGy.

Double badigeon à la bétadine. Antibioprophylaxie par Cefazoline 2000 mg. Après anesthésie locale, une incision est réalisée dans le sillon delto-pectoral gauche. Réalisation de la loge du stimulateur en pré-pectoral gauche. Fermeture par un surjet intradermique résorbable.
Stimulateur:.
- ASSURITY MRI DR ST JUDE PM2272 (St Jude) N° 5147685.

Sonde de stimulation:.
- SOLIA S 53cm (Biotronik) N° 8001916580.
- SOLIA S 60cm (Biotronik) N° 8001949991.

IMPLANTATION DE L'ELECTRODE ATRIALE DROITE (AURICULE).
Une électrode bipolaire de marque Biotronik (SOLIA S 53cm - 8001916580) a été implantée le 15/04/2025 par un abord céphalique gauche au niveau de l'auricule droit. Le seuil de stimulation est

de 0,6 Volts pour 0,4 ms. L'impédance de stimulation est de 525 Ohms. La détection est de 1,7 mV.

IMPLANTATION DE L'ELECTRODE VENTRICULAIRE DROITE (SEPTUM MID).
Une électrode de marque Biotronik (SOLIA S 60cm - 8001949991) a été implantée le 15/04/2025 par un abord céphalique gauche au niveau du ventricule droit (septum mid). Le seuil de stimulation est de 0,5 Volts pour 0,5 ms. L'impédance de stimulation est de 689 Ohms. La détection bipolaire est de 6,7 mV.

IMPLANTATION DU STIMULATEUR CARDIAQUE.
UN STIMULATEUR CARDIAQUE DE MARQUE ST JUDE (ASSURITY MRI DR PM2272 - 5147685) A ETE IMPLANTE LE 15/04/2025 DANS UNE LOGE PRE-PECTORALE GAUCHE.

ÉVOLUTION

a été hospitalisée pour implantation d'un stimulateur cardiaque double chambre pour bloc atrioventriculaire sur coeur sain

A l'arrivée en USIC, la patiente est stable sur le plan hémodynamique et eupnéique en air ambiant. L'ECG retrouve un rythme sinusal et régulier à 71 bpm, PR 200 ms, BBG complet QRS 140 ms, pas de troubles de la repolarisation. L'ETT retrouve un ventricule gauche non dilaté, non hypertrophié de fonction systolique segmentaire et globale préservée à 65% et une absence de valvulopathie significative.

Geste réalisé le 15/04/2025 : implantation d'un **boîtier de marque Saint-Jude**.

Absence de pneumothorax et sondes en place à la radiographie thoracique de J1.
Absence de saignement ou hématome de loge.

Contrôle du boitier le 15/04 par le Dr BIA :
- Sonde OD : détection 3.4mV, impédance 550 ohms, seuil de stimulation 0.75V0.4ms
- Sonde VD : détection 5.5mV, impédance 580 ohms, seuil de stimulation 0.5V0.4ms
- Programmation : DDD 60-130bpm

L'ECG de sortie montre un rythme sinusal 79bpm, BAV 1, BBG complet avec axe hypergauche

Ablation du pansement compressif le 17/04 par IDE.
Réfection du pansement tous les 2 jours par IDE jusqu'à cicatrisation, environ 10 jours. Fils résorbables, pas de nécessité d'ablation.

Sur le plan thérapeutique: arrêt du cardensiel et du furosemide.

Retour à domicile le 16/04/25.
Consultation de rythmologie pour contrôle du boitier dans 6 mois avec le Pr Lellouche.
Poursuite du suivi avec le cardiologue traitant.

Prescriptions de sortie

Médicaments

METFORMINE 1000 mg : 1 comprimé le matin, 1 comprimé le midi et 1 comprimé le soir
LERCANIDIPINE 20 mg : 1 comprimé le matin
RAMIPRIL 1.25 mg : 1 comprimé le soir
ATORVASTATINE 10 mg : 1 comprimé le soir
Lercanidipine 20mg: 1 cp matin
Aspegic 100mg : 1 cp matin

Seretide 250/25µg : 2 inhalations le matin et le soir
Thealose : 1 gtte x3/jour

Cardensiel 2.5mg: arrêt

Furosemide 40mg: arrêt

QSP 6 mois

Soins infirmiers

ORDONNANCE POUR SOINS LOCAUX POST-POSE DE DÉFIBRILLATEUR OU DE STIMULATEUR CARDIAQUE

Pour l'application de soins locaux sur la cicatrice opératoire tous les 2 jours pendant 10 jours suivant l'intervention:
- 1 flacon de BISEPTINE 500ml pour application locale.
- 1 boîte de 50 compresses stériles 10x10cm.
- 1 boîte de pansements MEDIPORE + Pad (avec compresse intégrée).

QSP 1 mois

ORDONNANCE POUR SOINS LOCAUX POST-POSE DE DÉFIBRILLATEUR OU DE STIMULATEUR CARDIAQUE

Effectuer réfection de pansement de la loge de PM/DAI, tous les deux jours pendant 10 jours (plus si nécessaire), dimanche et jours fériés inclus, par une IDE à domicile.

Fil résorbable, pas de nécessité d'ablation des fils

QSP 1 mois

AU TOTAL

Patiente de 72 ans hospitalisée pour syncope en lien avec un bloc atrioventriculaire de haut degré sur l'ECG post-critique (BAV 2:1)
Implantation d'un pace maker double chambre de marque ABBOTT.
Suites simples.

Planification des soins / Suites à donner

Rendez-vous pris
- 15/04/2025 à 12:00 : (--)
- 29/09/2025 à 13:30 : (BCT ORTHOPTIE)
- 29/09/2025 à 14:00 : (BCT CS OPHTALMOLOGIE)

Evénements recensés au cours de ce séjour :

- Information du patient / de sa famille : Oui
- Administration de produits sanguins labiles : Non
- Administration de produits dérivés du sang : Non
- Porteur / Contact BMR ou BHRe : Non
- Inclusion dans un protocole de recherche : Non
- Dispositif médical implantable permanent : Oui. PM Abbott
- Conseils hygiéno-diététiques donnés : Non
- Survenue d'évènements indésirable : Non

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Courrier non validé

Le document a été remis au patient lors de sa sortie

D. SM

Pour assurer votre prise en charge, l'AP-HP s'engage à collecter vos données personnelles (ex. : nom, prénom, antécédents médicaux) dans des outils numériques hautement sécurisés et conformément à la réglementation applicable.
Pour optimiser leur activité, certains services sont susceptibles d'utiliser des outils d'intelligence artificielle, avec une validation humaine.
Par ailleurs, certaines de vos données sont pseudonymisées (c'est-à-dire privées de toutes informations directement identifiantes) et rassemblées dans un entrepôt de données de santé (EDS), afin d'être réutilisées pour produire des indicateurs de pilotage de l'activité hospitalière, ou pour faire progresser la recherche sous réserve de l'avis du comité scientifique et éthique de l'EDS.
Pour information : retrouvez vos documents AP-HP sur le carnet de santé national Mon espace santé https://monespacesante.fr, ainsi que sur l'espace documentaire de votre Espace patient AP-HP https://mon.aphp.fr.
Pour plus d'informations sur le traitement de vos données personnelles et exercer vos droits, notamment d'opposition, rendez-vous sur https://www.aphp.fr/RGPD.

Copie à :
Madame